本章数字资源

第十四章 胸痛的全科医学处理

学习提要

- 胸痛是社区全科门诊常见的症状之一，分为心源性胸痛和非心源性胸痛。全科医生接诊时应首先排除高危胸痛和致命性胸痛，保证患者安全。
- 对于生命体征稳定的患者，详细询问病史、认真地体格检查并进行必要的辅助检查有助于找到胸痛的真正原因。
- 在关注胸痛诊断和治疗的同时，全科医生还应关注患者心理因素、胸痛对患者的影响等，最大限度地为患者提供帮助。

胸痛（chest pain）是一种临床常见的症状，发生率随年龄增加而逐渐上升。其病因可涵盖多个器官和系统，病情轻重不一；同时，胸痛的病变部位与疼痛部位、严重程度与疼痛程度并不一致，增加了医生的诊断难度。全科医生接诊胸痛时须进行规范化的评估，及时识别急性致命性胸痛，才能做到早诊断、早治疗，并避免出现猝死等严重后果。

临床病例

主观资料（S）：患者，男性，68岁，因“间断胸痛2年，加重2天”于社区卫生服务中心全科门诊就诊。

【问题1】接诊胸痛患者时，全科医生首先要注意什么？

思路：当全科医生首诊急性胸痛患者时，应首先考虑以下三个问题：第一，是否为胸痛？第二，是否为高危胸痛？第三，最可能的病因是什么？

胸痛是指胸前区的不适或疼痛感，发病时间 <72 小时的胸痛称为急性胸痛。为确保医疗安全和患者安全，全科医生一旦确定患者是急性胸痛发作，首先须识别和排除高危胸痛患者。应快速查看患者生命体征，如出现以下征象，则提示为高危胸痛，需要紧急处理：神志模糊或意识丧失；面色苍白；大汗及四肢厥冷；低血压；呼吸急促或困难；低氧血症（血氧饱和度 <90%）。对于高危胸痛的患者，在抢救的同时应积极明确病因，并在条件允许的情况下迅速转诊。对于无上述高危临床特征的胸痛患者，须警惕可能的潜在危险。对于生命体征稳定的患者，详细询问病史是病因诊断的关键。

知识点

胸痛的概念及常见病因

胸痛是指胸前区的不适或疼痛感，可覆盖胸前区从颈部到上腹部之间的区域，不同患者对胸痛的描述不同，如闷痛、针刺痛、烧灼样痛、紧缩感、压榨感等。需要警惕的是，胸痛不仅仅是胸部疼痛，如胸部、肩部、手臂、颈部、背部、上腹部或下颌疼痛，压力、紧张或不适，以及呼吸急促和疲劳，都应被视为心绞痛同等的症状进行分析。

导致胸痛的原因很多，一般分为心源性胸痛和非心源性胸痛。虽然大多数患者不会是心脏原因，但对所有患者的评估应侧重于早期识别或排除危及生命的原因。

【问题 2】作为一名全科医师，面对这位急性胸痛的患者应如何问诊？

思路：该患者间断胸痛 2 年，此次急性加重 2 天来就诊，全科医生应认真询问患者胸痛的起病特点（如起病缓急、诱因、加重与缓解的方式）、胸痛的主要特点（如胸痛部位、性质、严重程度、持续时间及有无放射痛等）、伴随症状、重要的阴性症状（如呼吸、心血管、消化及其他各系统高发疾病的表现）、诊疗过程（此次发病后诊疗过程及治疗效果）、既往史、个人史、家族史等，此外还应关注患者心理因素、胸痛对患者的影响等。

知识点

胸痛的分类

根据胸痛的风险程度，可将胸痛分为致命性胸痛和非致命性胸痛，也可根据胸痛与心血管系统的关系分为心源性胸痛和非心源性胸痛（表 14-1）。

表 14-1　胸痛的分类与常见原因

分类	病因
致命性胸痛	
心源性	急性冠脉综合征、主动脉夹层、心脏压塞、心脏挤压伤
非心源性	急性肺栓塞、张力性气胸
非致命性胸痛	
心源性	稳定型心绞痛、急性心包炎、心肌炎、肥厚型梗阻性心肌病、应激性心肌病、主动脉瓣疾病、二尖瓣脱垂等
非心源性	
胸壁疾病	肋软骨炎、肋间神经炎、带状疱疹、急性皮炎、皮下蜂窝织炎、肌炎、肋骨骨折、血液系统疾病所致骨痛等
呼吸系统疾病	肺动脉高压、胸膜炎、自发性气胸、肺炎、急性气管-支气管炎、胸膜肿瘤、肺癌等
纵隔疾病	纵隔脓肿、纵隔肿瘤、纵隔气肿等
消化系统疾病	胃食管反流病、食管痉挛、食管裂孔疝、食管癌、急性胰腺炎、胆囊炎、消化性溃疡和穿孔等
心理神经源性	抑郁症、焦虑症、惊恐障碍等
其他	过度通气综合征、痛风、颈椎病等

知识点

胸痛的问诊思路

全科医生应围绕胸痛的特点、高发疾病的表现、相关心理因素、胸痛对患者的影响、基础疾病、个人史、家族史等展开问诊。①胸痛的特点：胸痛的性质（阵发性灼痛、刀割样痛、压榨样痛），部位（胸骨后、心前区、侧胸），范围，频率（持续性、间断性），持续时间（数秒钟、数分钟、数小时），严重程度，诱发和缓解因素（活动、情绪激动、饱食后是否加重，休息、含服硝酸甘油是否缓解等），有无发热、咳嗽、咳痰、咯血、心悸、发绀、反酸、吞咽困难、呼吸困难等伴随症状及其严重程度，诊疗经过及治疗效果等；②胸痛高发疾病的问诊：如急性冠脉综合征、急性肺栓塞、主动脉夹层的危险因素及症状，如肺栓塞的患者可出现咯血、呼吸困难、气促甚至烦躁不安、濒死感等，有无口服避孕药和创伤史等；③识别引起胸痛的心理因素：如焦虑、抑郁等；④胸痛对患者的影响：鼓励患者自发地描述自己的症状，关注患者的个人感受和情绪反应，积极了解患者的想法、顾虑、担忧及期望，从而帮助患者正确认识疾病，尽量消除恐慌和焦虑，树立战胜疾病的信心；⑤基础疾病、个人史、家族史的问诊。

临床病例(续)

主观资料(S):患者2年前无明显诱因出现胸痛,表现为胸骨后压迫感,通常在快走或上楼时出现,不伴恶心、呕吐,无大汗及濒死感,每月发作1~3次,每次持续5分钟左右,可自行缓解,日常活动能力无明显下降,未予诊治。2天前无明显诱因出现胸痛,较前发作频繁,快走500m或上3层楼即可出现,仍为胸骨后压迫感,不伴恶心、呕吐,无大汗及濒死感,每天发作2~3次,每次持续5分钟左右,可逐渐缓解,日常活动略受限,安静状态无发作,夜间无发作,未用药,为进一步诊治,就诊于某社区卫生服务中心。

患者自起病以来,精神状态尚可,食欲可。平时睡眠好,近3天睡眠质量差,入睡困难,睡眠时间无变化。大小便无明显异常,体重无明显改变。

既往史:高血压病史10年,血压最高达160/100mmHg,未规律用药。

个人史:吸烟30余年,每天10支。不爱运动。饮食无特殊偏好。

家族史:父亲患冠心病,否认其他家族性遗传性疾病史。

其他:10天前邻居因急性心肌梗死猝死,之后一直担心自己会得冠心病,不敢去大医院诊治。

【问题3】根据该患者的症状,目前如何考虑可能的初步诊断?

思路:患者有典型心绞痛表现:胸骨后压迫感,与活动有关,每次持续5分钟左右,可自行缓解;近2天患者心绞痛诱因、发作频率均与既往不同。存在冠心病危险因素:老年、男性、家族史、高血压、吸烟、缺乏运动。根据病史初步考虑为冠心病、不稳定型心绞痛。

知识点

心绞痛的特征

典型心绞痛特征:大多为压榨样痛,发闷,有压迫感或紧缩感,可伴有焦虑或濒死的恐惧感。位置多为胸前区(即胸骨体上段或是中段后面),常向左肩、颈部、手臂放射。一般在体力活动(如用力排便、快速上楼、抬重物、爬山或体力劳动等)、情绪激动、寒冷、饱餐时发生。多数患者休息或含服硝酸甘油后3~5分钟内缓解。心绞痛发作时患者往往不自觉地停止原来的活动,直至症状缓解。

提示心绞痛的胸痛特征:表现为胸部压迫感或胸骨后疼痛,可表现为压迫感、紧缩感、烧灼感、刀割样或沉重感,或是无法解释的上腹痛或腹胀,可放射至下颌或牙齿、肩部、背部或左臂或双上臂。症状发作与活动、饱餐等增加心肌耗氧量的因素有关,休息后可自行缓解。

非心绞痛胸痛的特征:胸痛为锐痛,与呼吸或咳嗽有关;疼痛部位多变、不固定;胸痛与转动身体或按压身体局部有关;持续时间很短(<15秒)。非典型胸痛不能完全除外心绞痛。

【问题4】病史采集结束后,该患者初步诊断为不稳定型心绞痛,下一步体格检查应重点关注哪些方面?

思路1:该患者初步考虑不稳定型心绞痛,体格检查中首先应监测血压、呼吸、脉搏、体温等生命体征,重点进行心肺检查对明确诊断十分重要。心绞痛患者一般无明显异常的体征,但仔细体格检查能提供有用的诊断线索,可排除某些引起心绞痛的非冠状动脉疾病,如心脏瓣膜病、心肌病等,同时确定患者的冠心病危险因素(如高血压眼底改变、提示血脂异常的体征如黄色瘤)。少数患者心绞痛发作时可出现心率增快、血压升高、表情焦虑、皮肤温度低或出汗,或由于乳头肌缺血出现暂时性心尖区收缩期杂音。

思路2:部分体征有助于排除其他导致胸痛的疾病,如单侧肢体肿胀提示下肢深静脉血栓形成、肺栓塞可能,四肢血压差异明显提示主动脉夹层可能。

知识点

胸痛患者体格检查要点

所有就诊的胸痛患者均须监测血压、呼吸、脉搏、体温等生命体征，重点进行心肺检查对明确诊断十分重要。

一般情况：有无苍白、出汗，意识等。

视诊：观察皮肤是否有疱疹、红肿，是否有胸廓畸形等。

触诊：明确患者胸部、颈椎、胸椎是否有压痛、触痛。

叩诊：明确有无浊音、过清音，心浊音界是否扩大。

听诊：重点听诊肺部呼吸音、心率快慢、心律是否规整、心脏是否有杂音等。

双下肢：有无水肿、周径不对称、腓肠肌压痛等。

临床病例（续）

客观资料（O）：体格检查：体温 36.8℃，脉搏 80 次/分，呼吸 20 次/分，血压 150/90mmHg。身高 172cm，体重 90kg，BMI 30.42kg/m^2。神清，精神好。面容正常，全身未见皮疹，未触及淋巴结肿大。双肺未闻及明显干湿啰音。心率 80 次/分，律齐，心音有力，P2>A2，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛、反跳痛，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

【问题 5】结合上述体格检查结果，为明确诊断，该患者在社区卫生服务中心应进行哪些检查？

思路：根据病史和体格检查，该患者考虑不稳定型心绞痛，在社区卫生服务中心应立刻完善心电图、心肌酶检查，帮助全科医生明确诊断，除外急性心肌梗死可能。

知识点

胸痛常用辅助检查及其临床意义

在社区全科诊疗中，胸痛的常见病因包括肌肉骨骼、心血管、呼吸道、胃肠道疾病等。多数社区卫生服务中心没有大型检查设备，缺乏雄厚的技术团队，胸痛的诊断对于全科医生而言往往是一项难度较大的挑战，主要依靠的是全科医生的基本技能。准确的诊断来自详细病史（疼痛描述、相关症状以及疾病危险因素）、认真的体格检查及必要的辅助检查（心电图、胸部 X 线、心肌酶等）。

1. 心电图　所有胸痛患者均须进行心电图检查，急性胸痛患者应在接诊 10 分钟内完成首份标准 18 导联心电图检查。心电图是诊断缺血性胸痛的重要手段，包括静息心电图和症状发作时心电图，对于引起胸痛的其他疾病具有间接的提示意义。部分急性肺栓塞的患者心电图可出现 $S_IQ_{III}T_{III}$、肺型 P 波、右束支传导阻滞等右心负荷过重的表现。急性心包炎患者具有除 aVR 及 V_1 导联外广泛 ST 段弓背向下抬高。多数心绞痛患者发作时出现明显而特征性的心电图改变，常见发作时 ST 段压低≥0.1mV，缓解后恢复。T 波改变对反映心肌缺血的特异性不如 ST 段，但如与平时心电图比较有明显差别，也有助于诊断。静息心电图 ST 段压低或 T 波倒置的患者，心绞痛发作时可变为无压低或 T 波直立，称为“假性正常化”，也支持心肌缺血的诊断。

2. X 线胸片　X 线胸片适用于排查呼吸系统源性胸痛患者，可发现的疾病包括肺炎、纵隔与肺部肿瘤、肺脓肿、气胸、胸椎与肋骨骨折等。心脏与大血管的轮廓变化有时可提示主动脉夹层、心包积液等疾病，但缺乏特异性。

3. 心肌损伤标志物　是鉴别和诊断急性冠脉综合征的重要检测手段，其中高敏感性心肌肌钙蛋白是建立急性心肌梗死生物标志物诊断的首选标准，可以更准确地检测和排除心肌损伤。肌酸

激酶同工酶（CK-MB）对判断心肌坏死也有较好的特异性。心肌梗死后，肌钙蛋白 I（cTnI）在 2~4 小时后由心肌释放入血，10~24 小时达峰值。CK-MB 在起病后 4 小时内升高，16~24 小时达高峰，3~4 天恢复正常。

临床病例（续）

客观资料（O）：该患者心电图提示 P-QRS 正常；Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段水平型下移 >1mm；Ⅰ、V_5~V_6 导联 ST 段略下移。心电图诊断：窦性心律，ST 段改变。心肌酶检查正常。

【问题 6】结合上述资料，该患者目前考虑什么诊断？

思路：根据患者危险因素、典型心绞痛症状，近 2 天胸痛发作频率、特点较前有改变，心电图提示缺血性改变，心肌酶正常，考虑急性冠脉综合征、不稳定型心绞痛诊断成立。

知识点

急性冠脉综合征分类与快速识别

急性冠脉综合征包括 ST 段抬高型急性心肌梗死和非 ST 段抬高型急性冠脉综合征，后者包括非 ST 段抬高型急性心肌梗死和不稳定型心绞痛。心电图是早期快速识别急性冠脉综合征的重要工具，首次医疗接触后 10 分钟内应进行 12 导联心电图检查，如患者症状复发或诊断不明确，应复查 12 导联心电图。如怀疑患者有进行性缺血而且常规 12 导联心电图结论不确定，建议加做 V_{3R}、V_{4R}、V_7~V_9 导联心电图。

【问题 7】针对该患者的情况，还应注意和哪些疾病鉴别？

该患者心电图提示缺血性改变，心肌酶正常，初步排除 ST 段抬高型心肌梗死和非 ST 段抬高型心肌梗死，但应认识到急性心肌梗死有病情进展和演变的过程，须继续复查，观察心电图和心肌酶动态变化，进一步排除。

知识点

常见胸痛病因的鉴别诊断

1. 神经肌肉骨骼性胸痛　为最常见的胸痛原因，如胸壁疾病中的肋软骨炎、筋膜炎及胸椎疾病等，胸椎及背部疾病刺激脊神经诱发神经痛，也会导致患者感觉胸部疼痛。此类胸痛经常呈隐匿性和持续性，可持续数小时至数日；常为锐痛，局限于某一特定部位如剑突、胸骨体、胸肋关节处；多数胸壁疼痛与体位有关，可因深呼吸、翻身或手臂活动加重。查体可有固定部位的胸壁压痛。但胸壁压痛并不能排除严重冠状动脉疾病。

2. 消化系统疾病　如胃食管反流、贲门失弛缓症、消化性溃疡等，常见于既往溃疡病史、吸烟、应用非甾体抗炎药或其他有胃肠刺激的药物的患者。胃食管反流引起的胸痛多表现为胸骨后烧灼感或压榨感，卧位加重，坐起减轻，可伴反酸、吞咽困难，夜间反流常伴有咳嗽或喘息。

3. 心血管疾病　包括心绞痛、心肌梗死、心律失常、主动脉夹层等，是胸痛患者常见死因，常见于既往有冠心病、高血压病史，或有多种冠状动脉疾病危险因素患者。其中主动脉夹层患者常以突然发生的剧烈胸痛为主诉，多为刀割样、撕裂样的持续性疼痛，难以忍受，可伴有烦躁、面色苍白、大汗、四肢厥冷等休克表现。胸痛的部位与夹层的起源部位密切相关，随着夹层血肿的扩展，疼痛可向近心端或远心端蔓延。对于未明确诊断且具有上述危险因素的胸痛患者，应采用主动脉夹层筛查量表（表 14-2）进行初步筛查。结果为中度可疑或高度可疑的患者，须行影像学检查确诊，首选主动脉 CT 血管造影（CTA）。

表 14-2　主动脉夹层筛查量表

病史及体征	评分
病史满足以下任何 1 项：马方综合征、主动脉疾病家族史、主动脉瓣疾病、近期主动脉手术、胸主动脉瘤	1 分
胸痛特点满足以下任何 1 项：骤然出现、剧烈疼痛、撕裂样疼痛	1 分
体征满足以下任何 1 项：灌注不足表现（脉搏短绌、双侧收缩压不对称、局灶神经功能缺损），新发主动脉瓣关闭不全杂音，低血压或休克状态	1 分

注：评分 0 分为低度可疑，1 分为中度可疑，2~3 分为高度可疑。

4. 心理精神性胸痛　随着社会发展，生活节奏加快，群众对健康的需求增加，也导致心理精神性胸痛的发生率显著升高，需要全科医生注意鉴别。心理精神性胸痛常表现为隐痛或刺痛，疼痛位置不固定，多为左乳房偏下方区域，持续时间可长达数小时至数日，劳累或情绪激动时加重，常伴气短、心悸和疲乏无力，可伴有焦虑、抑郁、睡眠障碍等。须依据患者的具体病史及临床表现，结合必要的辅助检查，排除器质性病变后方能考虑。对于暂时无法确定病因的患者，须进行跟踪随访，尽可能确定病因，以确保患者及时获得相应治疗。

5. 肺部疾病　包括肺栓塞、肺炎、胸膜炎等。其中肺栓塞导致的胸痛比较危重，患者可有深静脉血栓形成、卧床、术后、肿瘤、妊娠等危险因素，可表现为胸痛、咯血、呼吸困难三联征，严重者可出现烦躁不安、惊恐甚至濒死感，部分患者以晕厥或意识丧失为主要表现。血压下降、休克提示大面积肺栓塞。肺与胸膜病变导致的胸痛多伴有咳嗽或咳痰、发热，常因咳嗽、深呼吸而使胸痛加重。自发性气胸好发于体型高瘦的年轻男性，诱发因素可为剧烈运动、咳嗽、提举重物或上臂高举及用力排便等。典型症状包括剧烈运动、咳嗽或用力排便后突发胸痛，继而出现胸闷、呼吸困难。少量气胸时肺部体征不明显，大量气胸时病变侧胸廓饱满，气管向健侧移位，叩诊呈鼓音，听诊呼吸音减弱或消失。X 线胸片是诊断气胸的可靠检查方法，可显示气管向健侧移位、肺压缩的程度等。

【问题 8】该患者在基层就诊应如何评估病情严重程度？

思路：按照不稳定型心绞痛的 Braunwald 分级，该患者属于不稳定型心绞痛Ⅲ级 B 组，同时患者无静息痛、血流动力学稳定，心电图未见明显的广泛 ST 段改变，初步评估为非高危的不稳定型心绞痛患者。

知识点

稳定型心绞痛的定义及严重程度分级

稳定型心绞痛通常为劳力性心绞痛，发作的性质在 1~3 个月内无改变。根据心绞痛的严重程度及其对体力活动的影响，加拿大心血管病学会（CCS）将稳定型心绞痛分为Ⅳ级（表 14-3）。

表 14-3　加拿大心血管病学会稳定型心绞痛分级

分级	心绞痛的严重程度及其对体力活动的影响
Ⅰ级	一般体力活动（如步行和登楼）不受限，仅在强、快或持续用力时发生心绞痛
Ⅱ级	一般体力活动轻度受限，快步行走、饭后、寒冷或刮风中、精神应激或醒后数小时内发作心绞痛。一般情况下平地步行 200m 以上或登楼一层以上受限
Ⅲ级	一般体力活动明显受限，一般情况下平地步行 200m 内或登楼一层引起心绞痛
Ⅳ级	轻微活动或休息时即可发生心绞痛

知识点

不稳定型心绞痛

以加拿大心血管病学会（CCS）的心绞痛分级为判断标准，非 ST 段抬高型急性冠脉综合征患者的临床特点包括：长时间（>20 分钟）静息型心绞痛；新发心绞痛，表现为自发性心绞痛或劳力性心绞痛（CCS Ⅱ级或Ⅲ级）；过去稳定型心绞痛最近 1 个月内症状加重，且至少具有 CCS Ⅲ级的特点（恶化型心绞痛）；心肌梗死后 1 个月内发作心绞痛。

不稳定型心绞痛患者临床表现严重程度不一，为选择个体化的治疗方案，必须尽早进行危险分层。危险分层须结合患者的病史、症状、生命体征和体格检查、心电图和实验室检查，作出初始诊断和最初的缺血性及出血性危险分层。不稳定型心绞痛高危患者的临床特点包括：持续 >20 分钟的静息心绞痛、血流动力学受影响、心电图有广泛的 ST 段改变或肌钙蛋白 T（cTnT）阳性。中危或低危的患者血流动力学稳定、心绞痛时间较短，且无缺血性 ST 段改变，cTnT 阴性。

Braunwald 根据心绞痛的特点和基础病因，对不稳定型心绞痛严重程度提出 Braunwald 分级（表 14-4）。全科医生还可使用简单的 TIMI 风险评分对患者进行缺血评估，包括 7 项指标，即年龄≥65 岁、≥3 个冠心病危险因素（高血压、糖尿病、冠心病家族史、高脂血症、吸烟）、已知冠心病（冠状动脉狭窄≥50%）、过去 7 天内服用阿司匹林、严重心绞痛（24 小时内发作≥2 次）、ST 段偏移≥0.5mV 和心肌损伤标志物增高，每项 1 分。TIMI 风险评分使用简单，但识别精度不高。

表 14-4 不稳定型心绞痛严重程度 Braunwald 分级

严重程度	定义	1 年内死亡或心肌梗死发生率/%
Ⅰ级	严重的初发型心绞痛或恶化型心绞痛，无静息痛	7.3%
Ⅱ级	亚急性静息型心绞痛（1 个月内发生过，但 48 小时内无发作）	10.3%
Ⅲ级	急性静息型心绞痛（48 小时内有发作）	10.8%
临床环境		
A	继发性心绞痛，在冠状动脉狭窄基础上，存在着加剧心肌缺血的冠状动脉以外的疾病	14.1%
B	原发性心绞痛，无加剧心肌缺血的冠状动脉以外的疾病	8.5%
C	心肌梗死后心绞痛，心肌梗死后 2 周内发生的不稳定型心绞痛	18.5%

临床病例（续）

初步评估（A）

诊断：①冠状动脉粥样硬化性心脏病，不稳定型心绞痛；②高血压 2 级，高危分层；③睡眠障碍；④焦虑状态。

健康问题：①高血压，未规律诊治；②吸烟；③肥胖；④缺乏运动。

处置计划（P）

诊断计划：联系上级医院，绿色通道转诊上级医院复查心电图，查心肌损伤标志物、血糖、血脂，必要时行冠状动脉造影。

治疗计划：①药物治疗：长期药物治疗应用硝酸酯类药物、β 受体拮抗剂、抗血小板药物、他汀类调脂药物，硝酸甘油用于心绞痛发作时急救；②休息：目前疾病不稳定期，限制活动量；③生活方式调整：低盐低脂饮食，戒烟，控制体重；④心理疏导。

NOTES

健康教育计划：①高血压、冠心病知识指导；②生活方式和行为指导；③用药指导；④自我保健知识指导；⑤患者家属教育。

【问题 9】该患者是否有转诊指征？转诊前应如何处理？

思路：该患者初步评估为急性冠脉综合征，不稳定型心绞痛Ⅲ级 B 组，既往间断胸痛 2 年，未规律诊治，近 2 天来无明显诱因出现胸痛，较前发作频繁，每次发作有活动诱因，且活动较前明显受限，尽管社区全科门诊检查未见心电图 ST 段抬高或明显演变，心肌酶正常，出于保障患者安全的考虑，建议转诊到心血管专科进一步明确诊断和治疗。

转诊前处理如下。

1. 一般治疗　嘱患者安静休息，避免心绞痛发作的诱因，饮食清淡，如心绞痛频繁发作可吸氧治疗，心绞痛发作时可舌下含服硝酸甘油。

2. 药物治疗　包括抗血小板药物、硝酸酯类药物、他汀类调脂药物等。

（1）抗血小板治疗：阿司匹林 100mg 每日 1 次、氯吡格雷 75mg 每日 1 次。

（2）β 受体拮抗剂：酒石酸美托洛尔 12.5mg 每日 2 次。

（3）他汀类调脂药物：阿托伐他汀 20mg 每日 1 次。

（4）硝酸酯类药物：单硝酸异山梨酯 20mg 每日 2 次。

3. 心理疏导　患者邻居 10 天前因急性心肌梗死猝死，导致患者一直担心自己会得冠心病，对患者进行心理疏导可减少患者的不良情绪、增强治病信心。

知识点

胸痛转诊指征

胸痛患者转诊指征如下。

1. 致命性胸痛。明确或怀疑心肌梗死，怀疑或证明肺栓塞或主动脉夹层，或其他严重威胁生命的疾病如张力性气胸时，在保证生命体征、采取适当急救措施的同时，须通过急救车转诊。

2. 怀疑或明确诊断器质性疾病，包括：①心绞痛：对药物治疗无反应的心绞痛；不稳定型心绞痛；心绞痛持续时间 >20 分钟（对舌下含服硝酸酯类药物无反应）须紧急入院治疗；②怀疑食管或其他胃肠道疾病（如十二指肠溃疡），须行内镜或适当的胃肠道检查；③其他器质性疾病，如肺炎、气胸、肿瘤、椎体病变等；④持续疼痛或功能障碍，可能须转诊到理疗科或疼痛科。

3. 非器质性胸痛，治疗效果不好或长期疼痛引起焦虑、抑郁等心理障碍者。

4. 其他需转诊情况。

知识点

初评非高危的不稳定型心绞痛患者转诊前处理措施

1. 一般治疗　疾病知识教育、生活方式指导、用药指导。

2. 药物治疗　包括抗血小板药物、硝酸酯类药物、他汀类调脂药物等。

（1）抗血小板治疗：阿司匹林是抗血小板治疗的基石，所有无禁忌证的患者均应口服阿司匹林，并以每日 75~100mg 的剂量长期服用。除非有极高出血风险等禁忌证，在阿司匹林基础上应联合应用 1 种 P2Y12 受体拮抗剂，并维持至少 12 个月。选择包括替格瑞洛（每日 2 次，每次 90mg 维持）或氯吡格雷（每日 75mg 维持）。建议非 ST 段抬高型急性冠脉综合征患者接受至少 1 年的双联抗血小板治疗，根据缺血或出血风险的不同，可选择性地缩短或延长双联抗血小板治疗的时间。

（2）β 受体拮抗剂：存在持续缺血症状的非 ST 段抬高型急性冠脉综合征患者，如无禁忌

证，推荐早期使用（24 小时内）β 受体拮抗剂，并建议继续长期使用，争取达到静息目标心率 55~60 次/分。

（3）他汀类调脂药物：如无禁忌证，应尽早启动他汀类调脂药物治疗并长期维持。

（4）硝酸酯类药物：非内皮依赖性血管扩张剂，具有扩张外周血管和冠状动脉的效果，有助于改善胸痛症状和心电图 ST-T 变化，症状控制后则没有必要继续使用。

3. 心理疏导　关注患者的个人感受和情绪反应，积极了解患者的想法、顾虑、担忧及期望，从而帮助患者正确认识疾病，尽量消除恐慌和焦虑，树立战胜疾病的信心。

知识点

急性心肌梗死患者转诊前处理

所有急性心肌梗死的患者均应及时转往上级医院就诊，在社区可采取以下初步处理和治疗。

1. 10 分钟内完成第一份心电图。无明显呼吸困难和心功能不全的患者须采取平卧位，存在心功能不全或急性肺水肿的患者须采取半坐位或坐位，必要时可使双腿下垂。对于有意识障碍的患者，应将其置于侧卧位以防止误吸。

2. 面罩吸氧或鼻导管吸氧（氧浓度一般为 2~4L/min），有明确低氧血症或存在左心衰竭的患者可予高浓度吸氧。

3. 开放静脉通路，监测血压、心率、脉搏、心律、肺部啰音及症状变化，在有条件的情况下进行心电监测，备好除颤仪，做好心肺复苏准备。

4. 所有无阿司匹林禁忌证的 ST 段抬高型急性心肌梗死的患者均应立即嚼服阿司匹林 300mg。

5. 如血压正常，可舌下含服或静脉应用硝酸酯类药物缓解缺血性胸痛、控制高血压或减轻肺水肿，注意监测血压，急性下壁、右室心肌梗死慎用。必要时可予吗啡止痛。

6. 向家属交代病情及可能采取的治疗方案，尽快联系转往上级医院。

7. 呼叫急救车转诊，尽量把患者送到有能力做急诊经皮冠状动脉介入（PCI）的医疗机构进行救治。

【问题 10】该患者转诊后可能在上级医院进行什么检查和治疗？

思路：该患者为不稳定型心绞痛，转诊后可能接受超声心动图检查明确心脏结构和功能，冠状动脉造影检查明确冠状动脉病变，同时还须进行相关血液学检查明确患者肝肾功能、血脂等情况。如冠状动脉造影结果提示冠状动脉狭窄，可能须接受冠状动脉再灌注治疗，同时接受指南指导的药物治疗（guideline directed medical therapy，GDMT），包括抗血小板药物、调脂药物、β 受体拮抗剂，根据患者病情使用肾素-血管紧张素系统抑制剂和硝酸酯类药物等。

临床病例（续）

该患者转诊上级医院后择期行冠状动脉造影检查，提示右冠状动脉近端 99% 狭窄，植入支架 1 枚。血脂检查提示 LDL-C 3.2mmol/L。

出院医嘱：酒石酸美托洛尔 25mg 每日 2 次，阿司匹林肠溶片 100mg 每日 1 次，氯吡格雷 75mg 每日 1 次，阿托伐他汀 20mg 每日 1 次，替米沙坦 80mg 每日 1 次。

【问题 11】该患者从综合医院诊疗后转回社区卫生服务中心，全科医师应如何进行社区管理？

思路：该患者从上级医院转回后的社区管理的内容应包括以下几个方面。

1. **建立健康档案**　详细记录患者发病情况、既往病史、家族史、生活方式（饮食、运动、吸烟、饮

酒)、家庭支持情况、经济情况等,并定期更新。

2. 控制危险因素　戒烟,控制体重(<24kg/m^2),适当运动,控制血压<130/80mmHg,低密度脂蛋白胆固醇<1.8mmoL/L。

3. 健康管理　对患者及其家属针对冠心病自我管理相关知识和自我管理技能进行健康教育,减轻患者心理负担。

4. 随访评估　每年提供至少4次面对面随访,及时记录随访情况,并根据随访结果调整患者管理计划。

知识点

冠心病患者社区管理要点

冠心病患者社区管理的内容包括以下几个方面。

1. 健康档案的建立和使用　凡是冠心病患者均应建立居民健康档案,详细了解患者发病情况、既往病史、早发心血管病家族史、生活方式(饮食、运动、吸烟、饮酒)、家庭支持情况、经济情况等。每次随诊时记录患者病情变化。

2. 控制危险因素

(1)戒烟、控制饮酒。

(2)控制体重至正常,正常BMI在18.5~23.9kg/m^2,BMI=体重(kg)/[身高(m)]^2。

(3)健康的生活方式。

(4)治疗高血压、糖尿病、血脂异常等。

3. 健康管理

(1)健康教育内容

1)疾病基本知识,如告知患者急性加重的症状,指导患者有病情变化及时就诊。

2)家庭保健知识,告知患者合理的饮食结构,进行规律适度的体力活动。

3)药物使用知识,告知患者在服用抗心绞痛药物治疗中可能会出现的不良反应及注意事项。告知患者冠心病药物治疗是长期治疗,切忌症状好转后自行减药或停药。如出现药物不良反应,建议并协助患者转诊至上级医院,并在1周内随访。

4)给予患者心理支持。

(2)健康教育方式:一对一个别指导、健康大课堂、健康小屋、同伴教育等。

4. 监测内容　包括目前症状、治疗情况、生活方式、体格检查、实验室检查等。

(1)症状:患者从上次就诊以来症状发作情况、有无新发症状。

(2)体征:血压、脉搏、心率、心律,超重或肥胖者监测体重指数(BMI)、腰围。

(3)生活方式评估及建议,服药情况,必要时调整治疗。

(4)根据病情定期做必要的辅助检查,包括血常规、尿常规、生化、心电图,有条件或必要时可选做超声心动图、颈动脉超声、X线胸片等。

5. 随访评估　对冠心病患者每年至少提供4次面对面随访。

(1)评估患者病情是否存在危急或其他须转诊情况。

(2)无须转诊的患者,询问上次随访到此次随访期间的症状。

(3)测量体重、心率、血压等,计算BMI。

(4)询问患者疾病情况和生活方式,包括心脑血管疾病、糖尿病、吸烟、饮酒、运动、摄盐情况等。

(5)了解患者服药情况和药物不良反应,必要时调整药物治疗方案。

(马　力)

思考题

1. 胸痛有哪几种分类方法？是如何进行分类的？
2. 胸痛患者的问诊要点有哪些？
3. 胸痛的转诊指征有哪些？
4. 社区卫生服务中心接诊 ST 段抬高型急性心肌梗死时，紧急转诊前应如何处理？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图